EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 71681
SERVICIO : CIRUGIA HSC
FECHA : 2023-10-02 12:53:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: ALBERTO QUINTANA TRONCOSO			RUN	: 13.602.955-K
F.Nac	: 09-09-1979	Edad	: 44 AÑOS	Género	: Masculino
Dirección	: EL ROBLE PJE. 5 SUR CASA 7			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA A	Teléfono	: null		
Fecha Ingreso	: 22-09-2023	Fecha Egreso	: 2023-10-02 12:53:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: DOMICILIO	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. I61.9-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

HIC frontoinsular derecha
Evacuacion Qx + captor PIC (11/09/23-> 14/09/23)
HTA
Obesidad

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. I61-HEMORRAGIA INTRAENCEFALICA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente el dia 10/09/23 presento caída a nivel, evoluciono con debilidad de hemicuerpo izquierdo y vomitos.
Consulto a urgencia en HSC, donde se objetivo déficit y se solicito TAC cerebro donde informa: Voluminosa HIC fronto-insular derecha con efecto de masa de 60 ml aprox + HSA moderada en cisterna y convexidad.
Se derivó a HHM, donde se tomo AngioTC cerebro sin aneurisma u otra MAV. Fue evcaluado por neurocirugía quien realizo evacuación quirúrgica la cual fue realizada sin incidentes el 11/09 y se instalo captor de PIC
Presento evolución favorable se logro extubar el 13/09 y se retira captor el 14/09, sin complicaciones de herida operatoria.
Fue dado de alta de neurocirugia
Se traslado a hospital de base, retirar puntos 21 dias posterior a cirugia.
Control al alta con neurocirugía y neurología.

Paciente con buena evolución durante estadía en HSC, fonoaudiología refiere lograr alimentación VO con chancado y papilla OK, test de masticación +.
Mayor movilización, pero mantiene paresia B-C izquierda.
Actualmente paciente en BEG; mas conectado con medio
Hemodinamia estable sin apremio ventilatorio
Afebril, diuresis ´+, deposicioenes +
Ex físico:
Alerta, vigil, ote
Píel rosada, mucosas hidratadas, llene capialr <2s
Mantiene paresia B-C izquierda, sin purito ocular
Cardiopulmonar: RR2T NAS. MP+ SRA
Abdomen: RHA´+ abdomen BDI, sin signos de irritación peritoneal.

PLAN DE MANEJO:

Continuar rehabilitacion con fonoaudiologia, kinesiologia x HODOM
Control con Neurocirugia en 1 semana en chillan

Control en neurología en 14 dias
Control en 14 dias con cirugia

INDICACIONES AL ALTA

1. Regimen chancado + papilla VO
2. Reposo relativo
3. Rehabilitacion con fonoaudiologia + Kinesiologia por HODOM
4. OMEPRAZOL CM 20 MG 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
5. PARACETAMOL CM 500 MG 2 comprimido cada 8 hrs. por 5 dias via ORAL
6. LEVETIRACETAM CM 500 MG 3 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
7. HIDRALAZINA CM 50 MG 1 comprimido cada 8 hrs. por 30 dias via ORAL
8. AMLODIPINO CM 10 MG 1 comprimido cada 24 hrs. por 30 dias via ORAL
9. TOBRAMICINA/DEXAMETASONA UNGUENTO 3,5 GRAMOS 1 unguento cada 8 hrs. por 4 dias via OFTALMICA
10. Control con neurocirugia en chillan en 7 dias
11. Control con neurologia en 14 dias
12. Control con cirugia en 14 dias

Control en: 14 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

NICOLÁS JAIME LETELIER ALARCÓN
MEDICO TRATANTE
17757150-4

JEFE SERVICIO